ИНСТРУМЕНТ 4 / 5

Клиничен планер в 4 етапа

Диагноза → Цели → Механика → Контрол. Формуляр за планиране за печат, попълван на ръка за всеки случай.

ПРЕДИ СТАРТА

Как се използва планерът?

Отпечатвайте формуляра за всеки нов случай; пазете го в досието на пациента.

Планът произтича от списъка на проблемите. Първо диагноза, после цел, накрая механика. Ако редът се наруши, лечението се удължава.

1. **Етап 1 · Диагноза** — Попълнете лице, оклузия, анализ на мястото, цефалометрия и ОПГ. За ОПГ използвайте Инструмент 1, за класификацията – Инструмент 3. Накрая запишете списъка на проблемите по важност.

2. **Етап 2 · Цели** — За всеки проблем запишете цел: лице, финал на моларите и кучешките зъби, overjet, overbite, средна линия. Решението за екстракция вземете с Инструмент 2; нуждата от анкораж определете тук.

3. **Етап 3 · Последователност на механиката** — Запишете в какъв ред ще постигнете целите. За всяка стъпка дъгата или помощният апарат са ясни. Отбелязвайте завършеното.

4. **Етап 4 · Контрол и финиширане** — Междинна ОПГ, препозициониране на брекети, 6-те ключа на оклузията и план за ретенция. Преди сваляне на брекетите всеки ред трябва да е отбелязан.

Правило

Празният ред е решение, което още не е взето. Преди да залепите брекетите, Етап 1 и 2 трябва да са пълни; после направете последната проверка с Инструмент 5.

Честа грешка

Да пишете последователността на механиката по навик. Първо трансверзална и ортопедична корекция, после нивелиране; без отворена дълбока захапка не се преминава към сагитална корекция.

Полета

Отбележете подходящия вариант; ако го няма в списъка, допишете го в края на реда.

Ревизия

Ако планът се промени, задраскайте стария ред и до него запишете датата и новото решение.

ПЛАНЕР · СТРАНИЦА 1

Етап 1 · Диагноза

Не преминавайте към Етап 2, преди документацията да е пълна.

Пациент / възраст / дата

Оплакване при първото посещение

Навик

☐ Смучене на палец ☐ Устно дишане ☐ Тласък на езика ☐ Бруксизъм

Лице

Профил

☐ Прав ☐ Конвексен ☐ Конкавен

Устни

☐ Свободни ☐ С усилие ☐ Протрудирани ☐ Ретрузивни

Средна линия на лицето / брадичка

Усмивка

☐ Излишна гингива ☐ Широк букален коридор ☐ Нормален

Оклузия

Молари / кучешки зъби (дясно · ляво)

Overjet / overbite (mm)

Средна линия горе / долу (mm)

Кръстосана / ножицовидна захапка

Крива на Spee

☐ Прав ☐ Умерен ☐ Дълбока

Функционално отклонение (CR–CO)

☐ Няма ☐ Има: ___ mm

ТМС

☐ Няма находка ☐ Звуци ☐ Болка ☐ Ограничено отваряне

Място, цефалометрия и документация

Нужда от място горе / долу (mm)

Bolton

☐ Съответства ☐ Излишък горе ☐ Излишък долу

SNA / SNB / ANB · Wits

FMA / SN-GoMe · IMPA / U1-SN

ОПГ (Инструмент 1)

☐ Без находки ☐ Има находка →

Пародонт / биотип

☐ Дебел ☐ Тънък ☐ Има рецесия

Растежен период

☐ Преди скока ☐ В скока ☐ Завършил

Диференциална диагноза (Инструмент 3)

☐ Дентален ☐ Скелетен ☐ Псевдо

Списък на проблемите (по важност)

ПЛАНЕР · СТРАНИЦА 2

Етап 2 · Цели

За всеки проблем – една цел. Целта трябва да е измерима.

Цел за лицето	☐ Запазете профила ☐ Намалете опората на устните ☐ Увеличете опората на устните
Финал на моларите дясно / ляво	☐ Клас I ☐ Пълен клас II ☐ Пълен клас III
Финал на кучешките зъби	☐ Клас I
Цел за overjet / overbite (mm)	
Средна линия	☐ Коригирайте ☐ Приемете
Позиция на резците	☐ Запазете ☐ Ретракция ☐ Контролирана проклинация
Трансверзала	☐ Не е нужно ☐ RME ☐ Дентоалвеоларно разширение
Вертикала	☐ Запазете ☐ Отворете дълбоката захапка ☐ Затворете отворената захапка
Решение за екстракция (Инструмент 2)	☐ Без екстракция ☐ Екстракция: _____
Нужда от анкораж	☐ Минимален ☐ Умерен ☐ Максимален
Средство за анкораж	☐ TPA ☐ Nance ☐ Мини винт ☐ Ластици

Приети граници / компромиси

Обяснено на пациента	☐ Варианти ☐ Продължителност ☐ Ретенция

ПЛАНЕР · СТРАНИЦА 3

Етап 3 · Последователност на механиката

Запишете последователността и отбелязвайте завършеното. Не преминавайте към следващата стъпка, преди да е завършена предишната.

✓	СТЪПКА	ДЪГА / АПАРАТ / ПОМОЩНО СРЕДСТВО	ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ
☐	Ортопедия / разширение		
☐	Нивелиране и подреждане		
☐	Дълбока захапка / крива на Spee		
☐	Затваряне на пространства		
☐	Сагитална корекция		
☐	Средна линия		
☐	Детайлизиране (торк, ротация)		

Етап 4 · Контрол и финиширане

Интервал на контролите

Междинна ОПГ (паралелност на корените) ☐ Планирано ☐ Направено

Препозициониране на брекети ☐ Не е нужно ☐ Зъби: _____

6-те ключа на оклузията
☐ Молари ☐ Ангулация на коронката
☐ Инклинация на коронката ☐ Ротация ☐ Контакт
☐ Оклузална равнина

Overjet / overbite / средна линия ☐ В целта

Ретенция горе ☐ Фиксиран лингвален ☐ Hawley ☐ Essix

Ретенция долу ☐ Фиксиран лингвален ☐ Hawley ☐ Essix

Риск от рецидив / бележка

ПРИМЕР

Попълнен пример

Измислен случай. За Вашия случай е достатъчно да пишете със същата подробност.

1 · ДИАГНОЗА

Пациент	*13 г., момиче. Оплакване: „Горните ми зъби са напред.“*
Лице	*Конвексен профил, ретропозиция на брадичката; устните се затварят с усилие*
Оклузия	*Молари и кучешки зъби в клас II двустранно; overjet 8 mm, overbite 5 mm; дълбока крива на Spee*
Място / Bolton	*Нужда от място горе 2 mm, долу 3 mm; Bolton съответства*
Цефалометрия	*SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°, IMPA 97°*
Друго	*ОПГ без находки; дебел биотип; в скока на растежа; без отклонение*
Диагноза (Инструмент 3)	*Скелетен клас II, подклас 1, мандибуларна ретрогнатия; при конструктивна захапка профилът се подобрява*
Списък на проблемите	*1) Сагитален (overjet) 2) Дълбока захапка 3) Лека скупченост 4) Некомпетентност на устните*

2 · ЦЕЛИ

Лице / сагитала	*Изведете мандибулата напред; молари и кучешки зъби в клас I*
Overjet / overbite	*2–3 mm / 2–3 mm*
Екстракция / анкораж	*Без екстракция (Инструмент 2: долните резци вече са проинклинирани, ще се следи); умерен анкораж*
Обяснено на пациента	*Сътрудничество при функционалния апарат, два етапа, продължителност на ретенцията*

3 · ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА МЕХАНИКАТА

1. Ортопедия	*Twin Block; редовен контрол на сътрудничеството*
2. Нивелиране	*Преход към фиксиран апарат: серия NiTi → стомана*
3. Дълбока захапка	*Изправяне на кривата на Spee, фронтална интрузия*
4. Детайлизиране	*Леки ластици клас II при нужда; торк и ротация*

4 · КОНТРОЛ И ФИНИШИРАНЕ

Контроли	*На равни интервали; паралелност на корените на междинна ОПГ*
Финиширане	*Проверка на 6-те ключа; overjet и overbite в целта*
Ретенция	*Горе Essix, долу фиксиран лингвален; риск от рецидив: проклинация на долните резци*

С образователна цел. Този материал не замества клиничния преглед, решението на лекаря и мнението на специалиста.

Следваща стъпка

Ако сте попълнили формуляра, преди да залепите брекетите **Инструмент 5 · Радар за грешки в планирането** Цялата логика на планирането е в **Модул 03 Клинично планиране: от списъка на проблемите до механиката** .